

مجمع مات طلبة عامّة

عن الأدوية , الأمراض , كيفية المعالجة
والتدخلات الواجبة للمعالجة

- ❖ لا يجوز استخدام دواء الـ (Voltarine) عن طريق IV "الوريد" ولكن فقط عن طريق "العضلة" IM . يعطى كمسكن عام لـ آلام العظام والمفاصل والكسور والمغص الكلوي...
- تحذير:** لا يعطى الفولتارين في حالات النزف الخاصة بالتقيؤ الدموي "تقيؤ فيه دم Haematemesis" او خروج فيه دم , وفي حالة من لديه قرحة المعدة والربو وارتفاع الضغط . ولذلك يعتبر من المحاذير لمرضى الضغط , والقرحة , والربو , وفي حالات النزيف كما هو الحال مع مضادات التخثر مثل (الهيبارين والورفارين والاسبرين) لا لا لا تعطى في حالة النزف لأنها تؤدي الى تميع الدم .
- ❖ الطفل الذي تتكون في فمه الفطريات نعطيه (Hestatine) لأنه قاتل للفطريات والبكتريا ولا نعطيه (Crysal violat) الحبر البنفسجي لأنه مؤذي للطفل وتأثيره أقل من الـ Hestatine .
- ❖ عند حدوث التهاب المجاري التنفسية مثل السعال لا نعطي للمريض (Caflex) بل نعطي (Amoxicilline) وذلك لان الـ (Caflex) يسبب Diarrhea عند المريض في هذه الحالة.
- ❖ عند حدوث قبض لدى الطفل نعطيه أغذية غنية بالألياف مثل (الخضراوات و الفواكه) وكذلك نعطيه سوائل وأدوية (Purgative) مسهلات .
- ❖ زيادة كمية الكوليسترول في الدم يؤدي الى حدوث حصي المرارة (كيس الصفراء Gallstone) .
- ❖ الأدوية المهدئة للسعال هي (Morphine – Codeine - Narcotine)
- ❖ Salbatamol يعالج الربو و ربو القصبات فهو يعتبر كموسع قصبات.
- ❖ عدم اعطاء المريض الـ (Asprin) في حالة حدوث النزيف لأنه يؤدي الى تميع الدم فهو يستخدم أيضاً كمضاد للتخثر anticoagulant .
- ❖ R "استميل" Chloropromazine "دواء يعطى في حالات : الشهاق "الشهاك" , الدوخة , ولعبان نفس (الغثيان) .
- ❖ فيتامين "B₆" يستخدم في حالات : التقيؤ فهو لا يمنع حدوث التقيؤ لكنه يؤدي الى تعويض النقص الحاصل من فيتامين B₆ في الجسم .
- ❖ أما فيتامين "B₃" يستخدم في : حالة التشنجات الحاصلة في العضلات أو للوقاية منها وأكثر المستخدمين له الرياضيين وذلك للوقاية من التشنجات وفيتامين "B₁₂" يستخدم لمعالجة فقر الدم خصوصاً في فترة الحمل . وفيتامين "B₁" وكل هذه الفيتامينات تعطى في حالات المرضى الذين يعانون من "الضعف Weakness" فهي تشتغل كمقويات للجسم .
- ❖ R (مسكوبان) "Hyosine Bytlbromide" دواء يعطى ضد التشنجات "antispasmin" التي تحدث في البطن , وآلام البطن , والاسهال والمغص .
- ❖ المريض الذي يعاني من التقيؤ والاسهال وآلام البطن نعطيه (فيتامين B₆ , مسكوبان , فلاجيل "Metronidazole" , نورمل سلاين أو رنكر) .

- ❖ **رَبْلَاسِيل "Metchlopromide"** دواء مضاد تقيؤ "Antiemetic" يعطى في حالات التقيؤ .
- ❖ **تحذير :** (مسكوبان وبلاسيل) لا تعطى في نفس الوقت لأن أحدهما معاكس لمفعول الآخر مما يؤدي الى اضطرابات في الجسم بمعنى أنه يجب أن يعطى أحدهم فقط للمريض .
- ❖ **تحذير :** "ترامال Tramadol" لا يعطى وحده فقط للمريض إلا بعد خلطه مع بلاسيل لأن اعطائه لوحده يؤدي الى التقيؤ المباشر ولذلك يجب خلطه مع البلاسيل لتفادي حدوث ذلك .
- ❖ **ترامال** يستخدم كمسكن للألم "قاتل الألم" مسكن مركزي اي انه يزيل الشعور بالألم الذي يحدث في الجسم من الدماغ "يفصل الشخص مركزياً من الدماغ فلا يشعر بالألم نهائياً" وهو ايضاً مادة مخدرة Narcotic يستخدم للآلام الحادة الشديدة فهو يستخدم بعد العمليات الجراحية ولا ينصح باستخدامه المتكرر لأن كثرة استخدامه تؤدي الى الإدمان Addiction على الدواء لاحتوائه على فعالية التخدير فهو مشتق من المورفين .
- تحذير :** من اجل الحفاظ على سلامة المريض : براستامول امبول وأمينوفلين امبول يجب ان تخلط مع 200 سي سي نورمل سلاين أو رنكر كي تخفف لأن اعطائها مباشرة يشكل خطر على حياة المريض .
- ❖ **ترانسيمينك أسيد (سايكلوكابرول) :-** يعطى لمنع النزف "منع انحلال الليفين" كالنزف في حالات الدورة الشهرية المضطربة والنزيف المتكرر من الانف Hemophelia .
- ❖ **في حالات عدم التطابق بين دم الزوج والزوجة يجب إعطاء أبرة "مطابقة" anti (D)Rh immunoglobulin** للأم خلال أول (72 ساعة) بعد الولادة وذلك لتجنب الآثار الجانبية المتوقع حدوثها للطفل بسبب عدم المطابقة بين دم الابوين التي تؤدي الى وفاة الطفل . *ملاحظة : يُقصد بعد المطابقة أن الـ Rh لكلا الابوين يكون مختلف قد تكون الام تحمل الصنف السالب والاب الموجب او العكس وهذا ما يسمى "عدم المطابقة" .
- **مرض الباقلاء "Favism" :-** هو مرض يسبب تكسر في كريات الدم (الحمراء) واكثر عضو يحدث فيه التكسر هو الطحال Spleen .
- **المريض الذي لديه عجز القلب "Heart failure" هناك حالتين الاولى :** اذا كان ضغط الدم نازل جدا نعطي نورمل سلاين ومعه "دوبامين أمبول" ليقوي عضلة القلب ويسرع النبض ليضخ اكبر كمية من الدم "يزرق ويخلط مع المغذي (ن,س) ثم يعطى للمريض ويبطئ لأن اذا أعطية (ن,س) وحده وبسرعة يسبب مباشرة "Cardiogenic shock" وبالتالي وفاة المريض , أما في الحالة الثانية : اذا كان الضغط مرتفع لا نعطيه مغذي "ن,س" لأن المريض يعاني من تجمع السوائل في الصدر بسبب توقف او قلة نشاط القلب في عملية الضخ ولذلك تتجمع السوائل لذلك لا نعطي المريض "مغذي" بل نعطيه فقط مدررات "Lazix" للتخلص من تجمع السوائل وأرجاع الضغط الى مستواه الطبيعي .
- **للتخدير الموضعي نستخدم ليدوكائين , أما للتخدير العام نستخدم بثديين أو مورفين** حيث انها تستخدم كمخدر ومسكن للجسم . Narcotic & Analgesic

- في حالة النزف من الأنف نضع "أدرنالين أمبول(أبينفرين)" على قليلاً من قطن طبي ثم وضعها في أنف المريض لأن الأدرنالين "يعمل على تقلص الشعيرات الدموية الموجودة في الأنف وبالتالي تتم السيطرة على النزف "الرعاى".

- المعدل الطبيعى للسكر فى الدم (Fasting 65-125mg/dl) يجب على المريض فى هذه الحالة أن يكون غير متناول للأكل لمدة 8 ساعات قبل فحص سكر الدم , أما فى حالة قياس سكر الدم بعد الأكل بساعتين أو أقل فأن المعدل الطبيعى (Random 140-199mg/dl)

- المعدل الغير طبيعى للسكر فى الدم مساوى أو اكبر من (Fasting 126mg/dl) , مساوى أو اكبر من (Random 200mg/dl)

- فى حالة الكسور بأنواعها يجب أخذ اشعة لموقع الكسر لمعرفة موقع ونوع الكسر بعدها نجري عملية التجبيس(back slab) للكسر عن طريق وضع كمية كافية من القطن على منطقة مناسبة وكافية ثم تحديد طول الجبس(هو شريط يحتوى مادة البورك) الذى سيوضع على الكسر وترتيبه على شكل طبقات عددها مناسب مع عمر الشخص المصاب بالكسر فالبالغين من الأفضل أن لا يقل عن 11 طبقة اما الاطفال أقل , ثم نغمر الجبس بالماء لمدة أقل من 5 ثواني ثم نرفعه ونعصره بلطف لتقليل مادة البورك ثم نضعه على القطن ونلف باللفاف , اذا امكن نجبر الكسر(ونعيده الى مكانه قدر الامكان) قبل اجراء عملية التجبيس(back slab) .

- بعد اجراء تخطيط للمريض اذا ظهر لديه Atrial Fibrillation ارتجاف الاذنين "الخفقان" نعطي للمريض نورمل سلاين فيه امبولتين كوردرون **Cordirone** الذى يعتبر جوكر لكل انواع الخفقان" ثم نفتح التسريب الوريدى للعلاج ببطيء شديد 7-9 قطرات بالدقيقة فقط .

- تحذير :- (Paracetamol ampule & Aminophiline ampule) يجب أن لا تعطى مباشرة بالوريد بل يجب أن تعطى بحقنها بـ 200 سي سي N/S او G/W فقط وليس G/S و لا Ringer وذلك للحفاظ على سلامة المريض .

- لا يجوز خلط اي نوع من الدواء مع Ringer او G/S لانه يؤدي الى امكانية حدوث تفاعل بين المواد وهذا التفاعل يغير من فعالية الدواء العلاجية مما يسبب اضطرابات لدى المريض .

- الانجسيد " "نتروكلايسيرين Angicid" يستخدم لأمراض القلب مثل الذبحة الصدرية والاعوية الدموية فهو يستعمل كموسع لـ الاوعية الدموية Vasodilation ولتخفيض ضغط الدم .

- الـ مانيتول Mannitol يستعمل بشكل اساسي لتقليل كمية الماء والصوديوم والاملاح والمواد الاخرى الموجودة خارج الخلية extracellular والتي تسبب تجمع السوائل "التورم Swelling" وترفع الضغط الى مستويات عالية مما يؤدي الى زيادة الضغط داخل القحف Intracranial Pressure "ICP الى اعلى من "15 mmHg" لأن المعدل الطبيعى للضغط داخل

القحف هو " 0 - 15mmHg " وان هذه الزيادة قد تؤدي الى الشلل فمحلول المانيتول يستخدم لمعالجة هذا الضغط لأنه يستخدم كمدرر للبول Diuretic حيث يستخدم لزيادة انتاج البول لدى الاشخاص المصابين بفشل كلوي حاد "ومفاجئ" وان هذه الزيادة في انتاج البول يساعد على منع الكليتين من التوقف وبسرعة ايضا يتم التخلص من بعض المواد السامة في الجسم عن طريق البول للحد من التورم Swelling وكذلك يستخدم لمعالجة الضغط داخل العين أو الضغط حول الدماغ "داخل القحف" كما ذكرنا .

- المحلول الملحي مفرط التوتر Hypertonic saline يستخدم ايضا لمعالجة ارتفاع الضغط داخل القحف "ICP" Intracranial Pressure ولا يمكن تفضيل المحلول الملحي مفرط التوتر على محلول المانيتول Mannitol في معالجة هذا الضغط لأن الدراسات التي أجريت على كل من المحلولين لتحديد الافضل بينهما من ناحية معالجة الضغط داخل القحف "ICP" لم تجد اختلافات احصائية بين المحلولين في هذا الجانب . م/ المعدل الطبيعي للضغط داخل القحف "0 - 15mmHg" .

الجلطة القلبية



هي موت قسم من عضلة القلب نتيجة قلة

وصول الدم والاكسجين الى القلب وأسباب ذلك تعود بالدرجة الاساس الى تصلب الشرايين (الذي يحدث بسبب الزيادة الحاصلة بنسبة الدهون بالدم , والتدخين , والسمنة وقلة النشاط والفعاليات الجسمانية) , و الخثرة والتقلصات في الشريان التاجي وكذلك مرض السكر Diabetes ومن الأسباب أيضا الإجهاد والحالة النفسية.

ومن أعراض الجلطة:- ألم في الصدر بحيث يحس المريض بوجود ثقل بمركز الصدر وتقلصه وصعوبة في التنفس خصوصا بعملية الشهيق , ولعبان نفس (غثيان) , وتقيؤ , قلق : المريض يصبح قلقا جدا خوفا من المجهول (الموت) , تعرق , شحوب الوجه , وعدم انتظام دقات القلب (Arrythemia) , وزيادة درجة حرارة الجسم لأسبوع واحد

✓ التدخلات الواجبة:-

⊗ الفحوصات التشخيصية:- نأخذ تاريخ ألم الصدر والتاريخ الصحي للمريض ونعمل E.C.G تخطيط قلب , ونفحص أنزيمات القلب .

⊗ المعالجة في الدرجة الاساس والأهم نعطي المريض الأوكسجين و مورفين سلفات Morphine Sulfate لأنه يقلل القلق , وتوفير راحة للمريض .

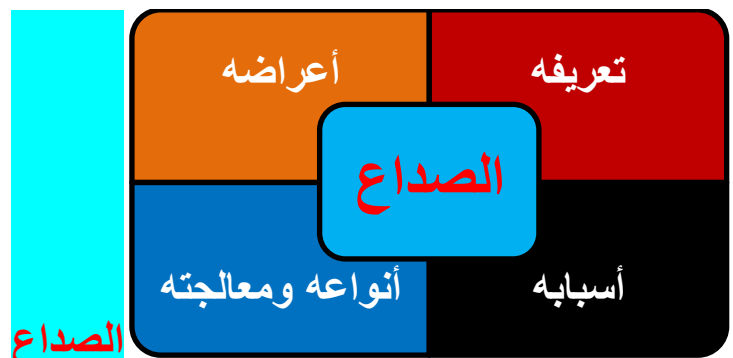
قرحة المعدة والاثني عشر GU and DU

هي مرض يحدث في المعدة والأمعاء ومن أسبابها :- بسبب بكتريا تسمى *Helicobacter Pylori* (H-Pylori) وبسبب كثرة إفراز الحوامض المعدية مثل الهيدروكلوريك HCL و Pepsin , وأيضا بسبب بعض الأدوية (NSAIDs) مثل: Voltarine, Aspirin, Diclophenac حيث أن هذه الأدوية تسبب 25% GU و 5% DU , نمط وأسلوب حياة الشخص مثل نمط التغذية , الحالة النفسية .

✓ **العلامات والأعراض :-** الشخص المريض ب(GU) قرحة المعدة يصبح عنده تقيؤ دموي Hematemesis وهذه العلامة مهمة ودليل مهم لمعرفة أن الشخص لديه قرحة في المعدة , وكذلك يحدث عنده حرقة في المعدة بعد الأكل بنصف ساعة , وكذلك يفقد المريض الشهية , وتصبح عنده , بينما الشخص المصاب بقرحة الاثني عشر (DU) يحدث لديه خروج دم مع الغائط Stool bleeding , تحدث حرقة في الاثني عشر بعد 2-3 ساعات بعد الأكل وهذه العلامتين تميز قرحة المعدة عن قرحة الاثني عشر .

✓ **معالجة القرحة :-** الأدوية المستخدمة في المعالجة:- 1. مواد (Antiacids) مضادات الحموضة لتقليل إفراز حامض HCL مثل Rantadine (Zantac) , Tagamet , omprazole .

2- مضادات حيوية مثل Metronidazole (Flagel) , Amoxilline



الصداع :- هو عارض وليس مرض أي أنه يحدث نتيجة

لسبب ما .

➤ **أعراضه :-** ألم شديد في الرأس يختلف مع اختلاف السبب , التقيؤ , غثيان (لعبان نفس) , دوخة , عدم الارتياح .

أسبابه :- بسبب عارض كالسقوط او امراض السقوط على الرأس الذي يسبب حدوث كدمات في الجمجمة مما يؤدي الى زيادة الضغط داخل الجمجمة وذلك يسبب الصداع..... الامراض كارتفاع ضغط الدم الحاد أو المزمن لان الارتفاع يؤدي الى توسع الاوعية الدموية في الدماغ وهذا يسبب الصداع , التهاب السحايا meningitis , اختلاف درجات البصر , الجيوب الانفية , الحالة النفسية .

أنواعه :- الصداع الحاد (يحدث ضمن فترة محدودة) , الصداع المزمن (يحدث بفترات أطول) , الصداع النصفي (داء الشقيقة) والذي يحدث في جانب واحد من الرأس من أعراضه التقيؤ حيث أن المريض يشعر بتحسن حالته بعد التقيؤ وهذا دليل واضح وعلامة واضحة على أن المريض لديه الصداع النصفي (داء الشقيقة) , الصداع في الجانب الامامي أو الخلفي من الرأس , الصداع في قمة الرأس.

معالجته :- تتم معالجة الصداع بمعالجة اسبابه لأنه عارض وليس مرض كما اشرنا فهو يحدث نتيجة لسبب ما كالسقوط على الرأس او امراض ففي حالة السقوط ينصح الشخص بمراجعة طبيب أخصائي جملة عصبية اذا كان لديه خسفات في الجمجمة او كدمات تسبب له الصداع لإجراء التداخلات الجراحية , أما في حالة الامراض كارتفاع الضغط يجب على المريض المراجعة لفحص الضغط وأخذ الادوية اللازمة للمعالجة , وكذلك الحال مع التهاب الجيوب الانفية والسحايا يجب اجراء الفحوصات وأخذ الادوية , وبالنسبة لاختلاف درجات البصر يجب على المريض مراجعة أخصائي العيون لإجراء الفحوصات اللازمة للعيون لتحديد درجة البصر وضغط العين وتخصيص نظارات مطابقة للفحص وهذا كله وأكثر يؤدي الى التخلص من الصداع بمستويات متفاوتة .

الحروق

في حالات الحروق نقوم بالإجراءات التالية :- تحضير الادوات ثم :

1- نزرق المريض ابرة مسكنة للألم "فولتارين" او مسكن ومهدئ مثل (ترامال) .

2- نعقم منطقة الحرق "بنورمل سلاين" أو "رنكر" .

3- نزيل الانتفاخات "بالكوز" ان وجدت وبقوة لإزالتها من المنطقة المحروقة لان بقاء هذه الانتفاخات يزيد الألم.

4- نضع على المنطقة المحروقة عصارة سلفر سلفا دايازين " هامازين " (Silver sulfadiazine)
"Hamazine"[®]) يشتغل كمضاد حيوي موضعي Topical antibiotic. وقد نخلط معها عصارة
زايلوكائيين يشتغل كمسكن للآلام .

5- بعد ذلك نلف المنطقة بـ "شاش خاص بالحروق" وهو شاش يحتوي على مادة دهنية تقلل من الألم
ثم بعد وضع هذا الشاش نلف باللفاف "البانديج" لكن بطبقة قليلة من الشاش .

***ملاحظة :** لا يجوز لف المنطقة المحروقة باللفاف بطبقات متعددة لان ذلك يزيد من الألم ولكن
نضع شاش رقيق بطبقات قليلة. ولا يجوز استعمال المعقمات "اليود أو الهبتين أو الديتول" في حالة
الحروق .

الجروح

في حالات الجروح نقوم بالإجراءات التالية :- تحضير الادوات ثم :-

1- نعقم الجرح بـ "نورمل سلاين" ثم بـ "اليود او مادة الهبتين" وذلك بوضع كمية مناسبة من اليود
على شاش "كوز" ثم مسح الجرح به الى ان يتم تعقيمه بشكل جيد وغالباً نستخدم اليود لأنه افضل في
التعقيم و له تأثير وفعالية تعقيمية اعلى من الهبتين .

2- نقوم بخياطة الجرح اذا تطلب ذلك باستخدام نوع خاص من الخيط يتلائم مع الجرح .

3- بعد اكمال الخياطة نضمد الجرح بوضع كوز عليه كمية من اليود ثم وضعها على الجرح ثم نلفها بـ
"البانديج" .

4- نزرق الشخص المجروح بإبرة خاصة ضد الكزاز "Antitetanus" . وكذلك ابرة "مضاد حيوي"
مثل "Pipracilin" للحد من حدوث التهابات .

*ملاحظات هامة :-

- لا يجوز استخدام "الكحول" في تعقيم الجروح والحروق .

- اليود أو الهبتين تستخدم في تعقيم الجروح والحروق لكن يفضل استخدام اليود بكثرة لأنه ذو فعالية
وتأثير اكبر من الهبتين . أما الديتول فأن تأثيره اقل من اليود والهبتين في التعقيم .

- في تعقيم الجروح والحروق نستخدم "نورمل سلاين" أو "رنكر" , أما "الكلوكوز سلاين" لا يمكن
استخدامه في التعقيم وهو من المحاذير لان البكتريا تنشط وتستفحل مع السكريات مما يؤدي الى
الالتهاب .

تعريف ضغط الدم :- وهو قوة دفع القلب للدم على جدران الاوعية الدموية "الشرايين" .

- في حالات هبوط الضغط نعطي السوائل التالية :

1- رنكر : وهو من السوائل التي تعيد ضغط الدم الى مستواه الطبيعية لكن يبطئ .

2- نورمل سلاين "أملاح متعادلة" : وهو من السوائل التي تعيد ضغط الدم الى مستواه الطبيعي بسرعة أكثر من "رنكر" ولذلك يفضل اعطائه للمريض في حالات الهبوط في الضغط الى مستويات منخفضة.

3- كلوكوز سلاين "سكر وأملاح" : يعطى في حالات الانخفاض في مستوى ضغط الدم ومستوى سكر الدم .

-أما في حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم :

نعطي للمريض مدرر "Furoseimide(Lazix)^R" وهو من المدررات التي تعمل على تخفيض نسبة الاملاح في الدم التي تطرح مع البول ولذلك تساعد في اعادة مستوى الضغط الى الحدود الطبيعية وننصح المريض بالإكثار من شرب الماء لأنه يزيد من عملية التبول .

وكذلك نجنب المريض اكل طعام يحتوي على الاملاح والدهون لأنها ترفع الضغط وننصح بأكل الحمضيات مثل "الليمون" الذي يساعد في معادلة الاملاح والحوامض في الدم مما يساعد في ارجاع ضغط الدم الى مستوياته الطبيعية . *اذن في حالة ارتفاع الضغط لا نعطي للمريض السوائل التي تعطى في حالة انخفاض الضغط فقط التي سبق ذكرها .

العجز الكلوي

✓ هو قصور في وظائف الكليتين او احدهما في تصفية الدم من المواد العالقة الزائدة عن حاجة الجسم كالأملح الزائدة والسكريات الزائدة والحوامض وغيرها .

❖ النفرون :- هو الوحدة الوظيفية الاساسية للكلية . ففي حالة عجز الكلية يتحطم عدد كبير قد يصل الى ملايين من هذه النفرونات وان هذا التحطم هو السبب الرئيسي لمرض العجز الكلوي اضافة الى اسباب اخرى .

❖ ومن اعراض العجز الكلوي : عند اجراء التحاليل المختبرية : ارتفاع مستوى اليوريا والكرياتينين واليورك اسيد في الدم , تجمع سوائل في الجسم (أنتفاخ) , ارتفاع الضغط . وغيرها من الاعراض .

"المغص الكلوي The Renal colic"

- وهو ألم حاد وشديد في المنطقة السفلى اليسرى أو اليمنى من البطن أو كلاهما وهو ذو ألم مغصي في طبيعته من أعراضه الغثيان والتقيؤ ويحدث الألم بشكل مفاجئ جداً ناتج عن وجود حصى في الحالب أو تكتلات في

الكليتين او احدهما مما يؤدي الى تجمع السوائل , المعالجة : مضاد
تشنجات مثل بسكوبان . ومسكنات مثل فولتارين . ومضاد حيوي مثل
جينتاميسين (كراميسين) .